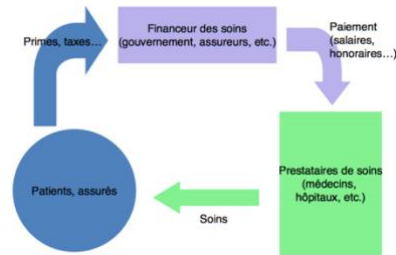


Assurance en santé

La **plupart** des personnes ont de **faibles dépenses** de santé par an (voire nulles). Cependant, certaines ont des dépenses de santé annuelles qui peuvent s'avérer être très importantes (plusieurs centaines de milliers de francs par an). Le principe de l'assurance est **d'offrir une protection financière** (devoir payer les dépenses de santé) via un mécanisme de mise en commun via un regroupement dans un pool de risques d'un grand nombre d'individus pour que **chaque individu alimente le fond commun** en versant une petite somme d'argent appelée prime. Le fond est ensuite utilisé pour dédommager les individus subissant une perte

Le système d'assurance santé cherche donc à **répartir les coûts sur l'ensemble de la population assurée** de manière à ce que chacun paie la moyenne des coûts.

Mettre en place un système d'assurance maladie nécessite un tiers payant (i.e. assureur) qui s'occupe **des flux financiers** en collectant les fonds des assurés et en versant les remboursements/paiements aux offreurs de soins. Cette instance peut être **une caisse d'assurance maladie, l'état ou encore un système de sécurité social**.



Le système de paiement par un tiers implique deux choses :

- Une instance qui **reçoit des paiements réguliers** (primes, taxes)
- Que le prix payé **directement par les assurés est réduit** (et parfois, disparaît). Le prix payé par les patients n'est donc pas égal au prix entier que vaut la prestation.

Ce système de paiement par un tiers **modifie également les comportements des agents** :

- **Aléa moral** : les comportements se modifient en présence d'assurance
- **Sélection adverse** : les personnes les plus malades veulent s'assurer, celles en bonne santé sont moins intéressées à le faire
- **Sélection des risques** : les assureurs préfèrent assurer les personnes en bonne santé
- (Demande induite)

1. Comportement des assurés

Le système d'assurance **augmente le bien-être** en réduisant le risque, mais il encourage à consommer des soins médicaux qui sont inefficaces. On distingue deux types d'aléas moraux :

- Aléa moral **ex post** (après être tombé malade) : concerne surtout l'excès de consommation de soins dû à la réduction du prix associé à l'assurance
- Aléa moral **ex ante** (avant l'arrivée de la maladie) : concerne surtout la baisse des activités de protection (diminution de la prévention, augmentation des comportements pathogènes) en présence d'assurances. Il semblerait que les personnes **bien assurées fassent moins d'exercice ou fumeraient davantage**

L'aléa moral peut être **réduit en imposant des mécanismes agissant sur la demande** notamment en imposant une participation financière de l'assuré. Cette participation peut se faire à trois niveaux :

- Co-paiement (*co-payment*) : **montant fixes payés par le patient** (forfaits) à chaque consommation de services de santé
- Coassurance (*co-insurance*) : **pourcentage des dépenses payées par l'assuré** à chaque consommation de services de santé, le reste par l'assurance
- Franchise (déductible) : montant des soins à **partir duquel l'assurance commence à rembourser**

2. Situation en Suisse

En Suisse, les assurés doivent **participer aux coûts des prestations** dont ils bénéficient dans le cadre de l'assurance de base (assurance obligatoire des soins), conformément à l'article 64 LAMal.

La franchise est un montant **fixe par année**. La franchise légale minimale est de 300 francs pour les adultes, il n'y a **aucune franchise pour les enfants**. Pour la *quote-part*, les assurés doivent payer eux-mêmes **le 10% des coûts** qui

dépassent la franchise. Le montant maximal annuel de la quote-part est de 700 francs pour les adultes et de 350 francs pour les enfants. Finalement, la contribution aux frais de séjour hospitalier (co-paiement) se monte à 15 francs par jour.

On s'attend à ce qu'une **élévation de la franchise conduise à une baisse du coût total des soins**, parce qu'une franchise **plus élevée renchérit le prix des soins**.

Si on observe, à un instant donné, une corrélation positive entre niveau de consommation (dépenses) de santé et niveau de franchise, et que le niveau de franchise peut être choisi par l'assuré, cette corrélation peut être due soit à un phénomène d'aléa moral (les assurés mieux couverts dépensent davantage) soit à un phénomène d'anti-sélection (lié à l'état de santé « connu » du consommateur et sa propension à consommer des soins; les personnes anticipant des dépenses élevées choisissent un niveau de couverture plus élevé, i.e. une franchise plus basse). On pense que les deux éléments sont combinés.

Le risque de mortalité est 3 fois plus grand pour les personnes ayant choisi la franchise la plus basse, par rapport à celles ayant choisi une franchise supérieure à 600 francs, ce qui démontre la présence d'un comportement d'anti-sélection dans le choix du contrat d'assurance.

Le problème associé à l'anti-sélection

Le problème d'anti-sélection est inhérent au problème d'asymétrie d'information entre l'assureur et l'assuré. L'assurance attire « en premier » les populations souffrant d'une forte morbidité. Ainsi, les « mauvais risques » tendent à être surreprésentés au sein de la population assurée. L'équilibre budgétaire de la compagnie d'assurance peut alors être mis en péril. Elle va donc augmenter les primes mais cela va aussi accentuer le problème en chassant les « bons risques ».

Les deux solutions sont d'obliger tout le monde à s'assurer et trouver des mécanismes de compensation des risques entre les caisses.

Assurance maladie en Suisse

La loi sur l'assurance maladie est caractérisée par les éléments suivants :

Caractérisée par

Assurance de base obligatoire

Participation aux coûts (cost-sharing)

contrat de base standardisé basé sur un panier bien défini standard (couverture des ttt hospitaliers et ambulatoires selon un catalogue exhaustif des prestations dans l'assurance obligatoire des soins, AOS)

même prime pour les adultes dans 1 caisse donnée pour un choix de contrat donné Libre-choix de l'assureur (parmi ceux proposant une prime dans la région) possibilité de changer de caisse obligation pour une caisse d'accepter tout assuré qui le demande

mécanisme de compensation des risques obligation de contracter avec les prestataires de soins séparation légale de l'assurance de base et de la complémentaire Subsidés pour le paiement des primes, sous condition de revenus

+ information facilement accessible et disponible

En Suisse, on compte plus **d'une cinquantaine de caisses d'assurance maladie**. Les caisses se font concurrence non pas sur la nature des prestations obligatoires, mais sur d'autres services qu'elles proposent. Les assureurs n'ont pas le droit de faire du profit et doivent séparer strictement les activités de base des activités complémentaires.

Il faut savoir qu'il existe une certaine **hétérogénéité des primes** entre les cantons. Il faut savoir que la variabilité est également importante à l'intérieur d'un même canton. Il existe différents types de franchise : franchise ordinaire, franchise à option et modèles alternatifs. Les trois modèles alternatifs sont le modèle HMO, le modèle médecin de famille et le Telmed. On

La répartition des modèles de franchise varie également entre les différents cantons. Depuis 1996, on a assisté à une augmentation de la proportion de personnes choisissant le modèle alternatif. Logiquement, les deux autres modèles ont diminué.

Les personnes choisissant les modèles alternatifs (utilise moins) ne sont pas les mêmes que celles qui choisissent la franchise ordinaire.

Switching des caisses

Pour la Suisse, en moyenne, les prestations représentent plus de 96% des primes. En somme, les primes sont hautes parce que les prestations sont hautes. Il y a donc finalement assez peu de marge entre prime et dépense. Le reste permet de constituer des réserves et de payer des frais administratifs.

Compensation des risques

Comme les assureurs doivent accepter de couvrir n'importe qui et que les risques sont différents entre les individus, un assureur risque d'avoir un portefeuille entièrement constitué de malades et donc de mauvais risques! Pour éviter une faillite, il y a donc une compensation des risques entre assureurs. A l'origine, cette compensation ne devait être que temporaire. Elle a depuis été prolongée, et améliorée. Elle permet aussi, en théorie, d'éviter la sélection des risques par l'assureur.